

がん薬物療法の役割

- ① 進行がんや他に効果的な治療法のないがんに対する**主治療**
- ② 外科的切除や放射線照射の局所治療後に行う**補助療法**
- ③ 外科的切除や放射線照射のみでは不十分な局所進行がんに対する**術前療法**
- ④ 放射線療法の効果を増強し，同時に遠隔転移を制御するための**化学放射線療法**
- ⑤ 中枢神経系などのsanctuary siteや特定の臓器に対する**局所療法**

がん薬物療法の目的

① 進行がんに対する薬物療法

✓ 完全治癒（高感受性のがん）

- 急性骨髄性白血病，急性リンパ球性白血病，ホジキンリンパ腫，中高悪性度非ホジキンリンパ腫，胚細胞性腫瘍，絨毛がん，胎児性横紋筋肉腫，腎芽腫（Wilms腫瘍）

✓ 生存期間の延長，症状緩和，QOL維持

② 術後補助化学療法

✓ 再発防止（再発リスクの高い患者が対象）

③ 術前化学療法

✓ 治療成績の向上，ダウンステージによる切除率の向上，縮小手術による整容性・機能温存，薬物療法の効果の評価。

④ 化学放射線療法

✓ 局所制御効果を高め遠隔転移を抑えて生存率を向上，臓器や組織の形態・機能の温存。

⑤ 局所薬物療法

✓ 腫瘍組織に選択的，あるいは薬物移行の悪い組織への抗腫瘍効果を期待

抗がん薬の適応

- ① 患者が薬物療法に耐えうる全身状態である。PSなどを慎重に吟味する。
- ② 主要臓器機能が保たれている。
- ③ 重篤な合併症がない。
- ④ 患者に薬物療法を受ける意欲がある。文書による同意が得られている。

ECOGのPerformance Status

PS0	無症状で生活に支障なく，発病前と同じ日常生活を制限無く行うことが出来る。
PS1	激しい肉体活動は制限されるが，歩行可能で，家事や事務仕事など軽作業や座位での作業は行うことが出来る。
PS2	歩行可能で，身の回りの事は自分で行えるが，作業は出来ない。日中の50%以上はベッドの外で過ごしている。
PS3	限られた自分の回りの事しか出来ない。日中の50%以上を臥床状態で過ごしている。
PS4	全く動けず，自分の身の回りの事も全く出来ない。完全に臥床状態もしくは椅子の上で過ごしている。

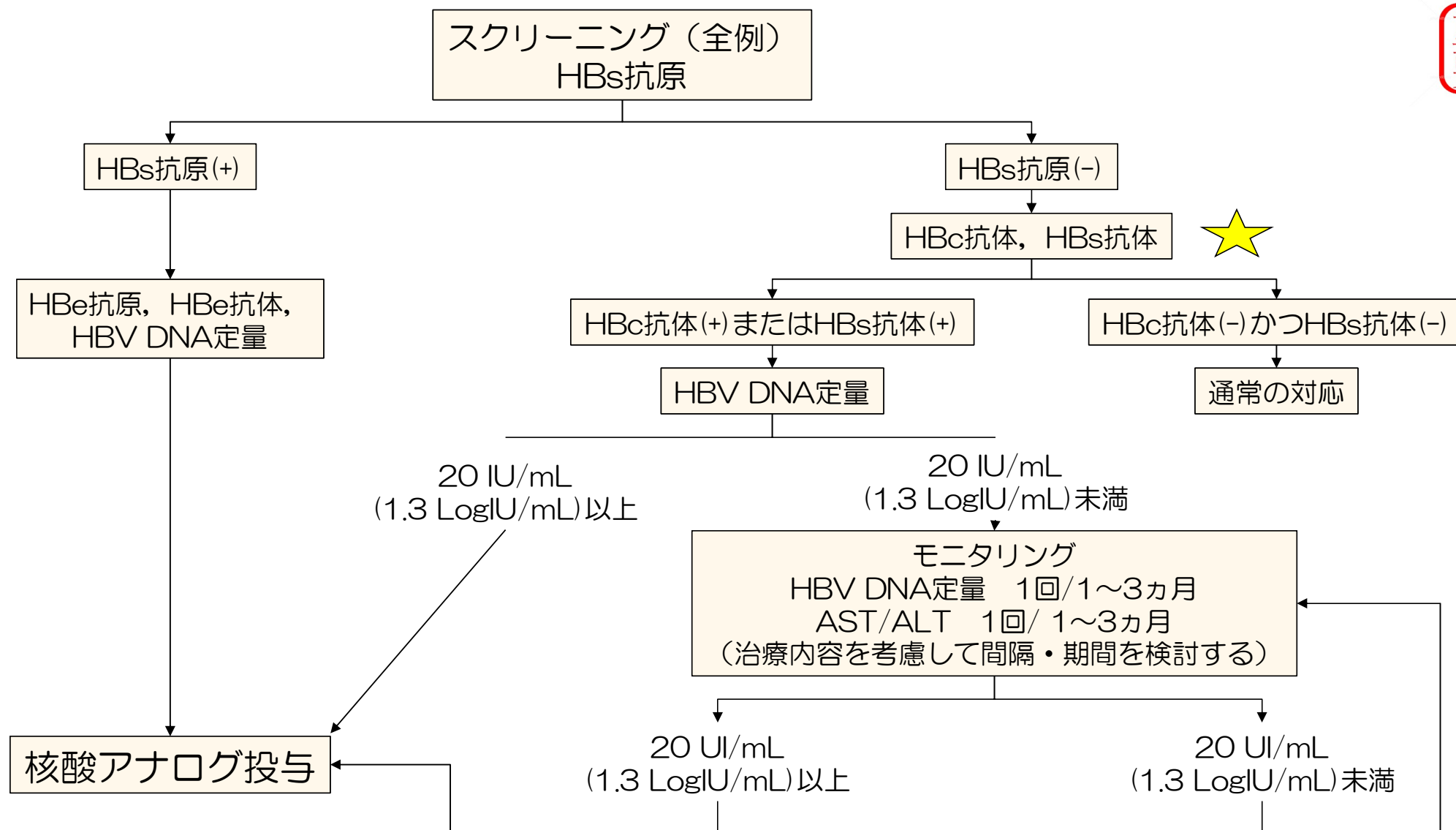
化学療法の実施時の注意点

- 治療前に以下をチェック
 - PS、身長、体重、自覚症状、他覚症状、血液検査結果（ウイルス肝炎関連検査を含む）
 - CTなどの画像で病変を評価
- 治療効果は適切な画像診断を用いて、原則として2～3ヵ月毎に判定する。腫瘍縮小割合は、胃癌取扱い規約、RECIST等により判定し、治療継続の参考とする。
- 治療開始後は、有害事象（CTCAEで評価）と効果を勘案し、継続の可否および休薬、薬剤投与量変更の要否を判断する。
- B型肝炎ウイルス（HBV）キャリアおよび既感染者に対しては、HBV再活性化予防のため、ガイドライン*に沿って対策を行う。

*日本肝臓学会 肝炎診療ガイドライン作成委員会／編 「B型肝炎治療ガイドライン（第3版）」2017年8月版

免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドライン

重要



がん薬物療法の実際

- 外来・入院のいずれにおいても治療可能.
- 有害事象の評価を行う.
- 出現した有害事象に対して、適切な支持療法を行い、抗がん薬の休薬、延期、減量を行う。（安易な減量や治療中止は生存期間の延長が得られない可能性がある）
- 定期的にCTなどで有効性の評価を行う．RECISTによる評価を参考にする（SD以上は治療継続など）．
- PDであった場合や重篤な有害事象が発生した場合は、治療の適応を再評価し、次の標準治療へ変更する.
- 緩和医療に移行するタイミングを逃さないこと.

有効性の評価：RECIST（Response Evaluation Criteria in Solid Tumors）

安全性の評価：CTCAE（Common Terminology Criteria for Adverse Events）

